

---

QCM · CONCOURS

---

# Concours-Radiologie-National-2019-IDE

---

44 questions

## Questions

**1** Lorsqu'un patient se présente pour la première fois au niveau d'un service de RX, on commence par :

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>A</b> | Les incidences fondamentales   |
| <b>B</b> | Les incidences complémentaires |
| <b>C</b> | Les variantes                  |
| <b>D</b> | Les incidences de nécessité    |

**2** Le centrage bassin de face :

- |          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | On centre à 2 travers de doigts au dessus de la symphyse pubienne |
| <b>B</b> | On centre à 1 travers de doigts au dessus de la symphyse pubienne |
| <b>C</b> | Les ailes iliaques sont dégagées strictement de face              |
| <b>D</b> | Les ailes iliaques sont dégagées en oblique                       |

**3** Pour un patient présentant une fracture du col fémoral, la ou les examens radiologiques de choix à réaliser :

- |          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Face de la hanche sans rotation interne et l'incidence urétrale  |
| <b>B</b> | Face de la hanche avec rotation interne et l'incidence urétrale  |
| <b>C</b> | Face de la hanche sans rotation interne et l'incidence d'Arcelin |
| <b>D</b> | Face de la hanche sans rotation et l'incidence urétrale          |
| <b>E</b> | Face de la hanche sans rotation et l'incidence d'Arcelin         |

4 Parmi les critères de réussite du  $\frac{1}{4}$  alaïre du bassin :

- A Les limites du trou obturateur sont superposées
- B Cotyle vue de face
- C Cotyle de profil
- D Le trou obturateur est ouvert

5 Quelle est la ou les incidences du profil de la hanche qui permettent d'utiliser le Potter ou le portique :

- A Incidence d'Arcelin
- B Incidence urétrale
- C Incidence de Lequesne
- D Incidence de salpêtrière Face en antéropostérieur

6 Parmi ces incidences, la ou les incidences fondamentales dans l'exploration de l'articulation coxo-fémorale :

- A Profil de Lequesne et de « Desèze »
- B L'incidence de face
- C Profil d'Arcelin (externe)
- D Profil urétral (externe)

7 Les incidences axiales du genou ou défilés rotuliens : 30°, 60° et 90° :

- A Le patient en décubitus dorsal
- B La cassette est maintenue sur la face antérieure des fémurs par le patient
- C Angle mesuré est le prolongement de l'axe du fémur avec l'axe de la jambe
- D Angle mesuré est l'axe du fémur avec l'axe de la jambe

8 Un patient qui ne peut pas faire l'extension complète de la jambe sur la cuisse, se présente au service RX, La ou les incidences de choix à réaliser sont :

- A Face en postéro-antérieur
- B Profil avec RDH
- C Profil avec RDV
- D Face en antéropostérieur

9 Vous recevez un enfant âgé de 3 ans accompagné par sa maman pour une fracture ouverte de la jambe. Votre conduite par rapport à la maman en cas de refus de l'enfant de rester seul :

- A Forcer l'enfant de rester seul
- B Autoriser la maman de rester près de son enfant en portant une blouse plombée
- C Autoriser la maman de rester près de son enfant sans blouse plombée
- D Demander de l'aide auprès des accompagnants d'autres malades

10 Quelles sont les incidences nécessaires à réaliser pour cet enfant :

- A Jambe de face
- B Poumon en DD
- C Jambe de profil avec RDH et patient en décubitus dorsale
- D Jambe de profil avec RDV et patient en décubitus latérale

11 L'incidence verticale du calcanéum, retro-tibiale descendante :

- A Est réalisée patient debout
- B On centre sur la face interne du pied en son milieu
- C Peut être réalisée de manière symétrique
- D Permet d'explorer la partie postérieure du calcanéum

**12** Centrage de l'incidence Schreck II (scaphoïde de profil) :

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | RD incliné de 10° vers la tête centré sur l'interligne radio-carpienne |
| <b>B</b> | RDV centré sur l'interligne radio-carpienne                            |
| <b>C</b> | RDV centré à 1 cm au-dessus de l'interligne radio-carpienne.           |
| <b>D</b> | RDV centré à 1 cm au-dessous de l'interligne radio-carpienne           |

**13** L'incidence oblique interne de la main :

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Main en appui cubital, le plan de la paume fait un angle de 45° avec la verticale |
| <b>B</b> | On centre sur la tête du 1er ou du 2ème métacarpien                               |
| <b>C</b> | On centre sur la tête du 3ème ou 5ème métacarpien                                 |
| <b>D</b> | Sur le cliché on voit les métacarpiens superposés                                 |

**14** L'incidence coude de profil :

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Main en pronation, l'avant-bras fléchi à 135° (90° pour Clark)                     |
| <b>B</b> | Main en demi- pronation, l'avant-bras fléchi à 135° (90° pour Clark)               |
| <b>C</b> | RD centré verticalement sur l'interligne à 1 cm environ au dessous de l'épicondyle |
| <b>D</b> | RD centré verticalement sur l'interligne à 1 cm environ au dessus de l'épicondyle  |

**15** Le centrage de l'incidence de l'apophyse coronoïde :

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| <b>A</b> | Au milieu de l'interligne radio-humérale  |
| <b>B</b> | Au milieu de l'interligne radio-cubitale  |
| <b>C</b> | Au milieu de l'interligne cubito-humérale |
| <b>D</b> | Toutes les réponses sont justes           |

16 Pour étudier la palette humérale de profil, il faut :

- A L'axe épicondyle-épitrochlé soit parallèle au film
- B Main en supination
- C L'axe épicondyle-épitrochlé soit perpendiculaire au film
- D Main en pronation

17 Le centrage de l'incidence profil trans-thoracique de l'épaule :

- A RD incliné de 15° vers le bas visant l'épaule malade à travers le creux axillaire du côté sain.
- B RD incliné de 15° vers le haut visant l'épaule malade à travers le creux axillaire du côté sain.
- C RD incliné de 25° vers le bas visant l'épaule malade à travers le creux axillaire du côté sain.
- D RD horizontal visant l'épaule malade à travers le creux axillaire du côté sain.

18 Pour un patient qui présente un traumatisme au niveau de l'épaule, la ou les incidences de choix à réaliser :

- A Face de l'épaule en rotation externe
- B Face de l'épaule en rotation neutre
- C Bernajean
- D Profil trans-thoracique

19 Le centrage de l'incidence clavicule de face en postéro-antérieur :

- A RDV centré sur l'angle sup-externe de l'omoplate
- B RDV centré sur l'angle sup-interne de l'omoplate
- C RD incliné de 20° centré sur l'angle sup-externe de l'omoplate
- D RD incliné de 20° centre sur l'angle sup-externe de l'omoplate

*! Options C and D are nearly identical in text transcription.*

20 Le centrage du rachis cervical de profil peut être :

|   |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | RDH à mi-hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule sur la ligne des épineuses                              |
| B | RDH à mi-hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule à 2travers de doigts en avant de la ligne des épineuses |
| C | RDV à mi hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule sur la ligne des épineuses                              |
| D | RDV à mi hauteur entre l'angle de la mâchoire et l'épaule à 2travers de doigts en avant de la ligne des épineuses |

21 La ou les indications du rachis cervical de face debout :

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| A | Recherche de traumatisme                     |
| B | Douleurs cervicales                          |
| C | Hauteur des disques intervertébraux          |
| D | Etude statique et appréciation morphologique |

22 Parmi les critères de réussite du rachis cervical de face :

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A | Position médiane de la ligne des épineuses                                      |
| B | Dégagement de tous les interlignes intervertébraux et articulaires postérieures |
| C | Position symétrique du maxillaire inférieur                                     |
| D | Bonne visibilité des disques intervertébraux de C3C4 à C7D1                     |

23 La ou les incidences qui permettent de voir le rachis cervical entier de face en effaçant la mandibule :

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Incidence cervical de face debout                                                  |
| B | Incidence cervical de face en demandant au patient de fermer et d'ouvrir sa bouche |
| C | Incidence de Pélissier                                                             |
| D | Incidence de Dorland                                                               |

24 Parmi les incidences radiologiques suivantes, lesquelles faut-il réaliser chez un sujet présentant une névralgie cervico-brachiale (NCB) :

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| A | Incidence de face du rachis cervical   |
| B | Incidence de profil du rachis cervical |
| C | Incidence de profil de la C.C.O        |
| D | Incidences obliques du R.C             |

25 La position du patient dans l'incidence du rachis dorsal en oblique antéropostérieure :

|   |                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Patient debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° du plan d'examen                |
| B | Patient debout, le côté opposé à lui radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° du plan d'examen     |
| C | Patient debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° du plan d'examen                |
| D | Patient debout, le côté opposé à celui à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° du plan d'examen |

26 L'incidence du sacrum de face, le patient est :

|   |                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|
| A | Décubitus dorsal membres inférieurs en extension RD ascendant de 15°  |
| B | Décubitus dorsal membres inférieurs en extension RD descendant de 15° |
| C | Décubitus dorsal membres inférieurs en extension RD ascendant de 20°  |
| D | Décubitus dorsal membres inférieurs en extension RD descendant de 20° |

27 Le RD de l'incidence du Coccyx de face en postéro/antérieur

|   |                   |
|---|-------------------|
| A | Descendant de 10° |
| B | Ascendant de 10°  |
| C | Descendant de 20° |
| D | Ascendant de 20°  |



28 La ou les incidences de choix à réaliser pour une patiente qui présente une lésion osseuse des côtes avec une éventuelle extension vers la plèvre :

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| A | Grille costale de face debout                |
| B | Grille costale de face en décubitus dorsale  |
| C | Grille costale de profil en décubitus dorsal |
| D | Grille costale en oblique debout             |

29 Pour réaliser l'incidence de sternum de face :

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| A | Malade en O.A.D de 20° à 30° en station verticale R.D.H |
| B | Malade en O.P.D de 20° à 30° en station verticale R.D.H |
| C | Malade en O.P.G de 20° à 30° en station verticale R.D.H |
| D | Malade en DV, le R.D oblique de 20° à 30°               |

30 Pour définir une incidence qui permet d'explorer radiologiquement le crâne, il suffit d'indiquer :

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | Les résultats normaux               |
| B | Les variantes de cette incidence    |
| C | L'angle du rayon directeur          |
| D | Un point de centrage bien déterminé |

31 Le centrage de l'incidence crâne d'ensemble de profil :

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| A | Point situé à 4cm au dessus du tragus                                     |
| B | Point situé à mi-distance entre le tragus et l'apophyse orbitaire externe |
| C | Le point situé à 2 travers de doigts en avant et au dessus du tragus      |
| D | Le point situé à 4cm au dessus et à 2cm en avant du tragus                |

32 La ou les incidences qui permettent d'explorer la base du crâne :

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| A | Semi axiale (Worms)                                          |
| B | Face haute                                                   |
| C | Profil                                                       |
| D | Axiale (Hirtz) et ses variantes (Sub-axiale et hyper-axiale) |

33 L'angulation et le centrage de l'incidence Blondeau :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| A | -50° vise le nasion   |
| B | -50° vise l'acanthion |
| C | +50° vise le nasion   |
| D | +50° vise l'acanthion |

34 La ou les incidences de choix à réaliser pour un patient qui se présente au service de RX pour une sinusite de contrôle sont :

|   |                           |
|---|---------------------------|
| A | Profil                    |
| B | Blondeau                  |
| C | Schuller II               |
| D | Plancher dans les orbites |

35 Le centrage de l'incidence qui permet de dégager l'articulation temporo-maxillaire (Schuller I)

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| A | 6,5 cm au dessus du conduit auditif externe       |
| B | 4,5cm au dessus du conduit auditif externe        |
| C | 2cm au dessus du conduit auditif externe          |
| D | Rase le bord supérieur du conduit auditif externe |

36 Les images radiologiques au niveau du grêle en cas de niveaux hydro-aériques sont :

|   |                         |
|---|-------------------------|
| A | Plus larges que hautes  |
| B | Périphériques           |
| C | Plus hautes que larges  |
| D | Nombreuses et centrales |

37 La ou les techniques qui permettent de visualiser un pneumopéritoine :

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| A | ASP en décubitus latéral avec rayon horizontal |
| B | ASP de profil avec rayon vertical              |
| C | ASP en décubitus dorsal                        |
| D | ASP de face debout                             |

38 Dans l'incidence poumons de face de décubitus dorsal, on centre :

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| A | Sur la fourchette sternale                  |
| B | A l'appendice xiphoïde                      |
| C | A 8 cm au dessous de la fourchette sternale |
| D | A 2 cm au dessus de la fourchette sternale  |

39 Dans l'incidence de poumons de face en Trendelenburg ; l'inclinaison de la table est de :

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
| A | 30° de sorte que la tête soit plus basse que les pieds |
| B | 30° de sorte que les pieds soient plus bas que la tête |
| C | 60° de sorte que la tête soit plus basse que les pieds |
| D | 60° de sorte que les pieds soient plus bas que la tête |

40 En cas d'œdème pulmonaire (OAP) il faut :

- A O2
- B Faire la position demi-assise
- C Injecter par voie intraveineuse le lasilix
- D Injecter l'adrénaline

41 Les structures suivantes font partie du réseau hospitalier :

- A Les centres d'oncologie
- B Le centre de croissant rouge marocain
- C les centres de santé
- D La Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires (DHSA)

42 Une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontière est appelée :

- A Épidémie
- B Pandémie
- C Endémie
- D Cas sporadique

43 L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée de :

- A Le réseau des établissements des soins de santé primaires
- B Le réseau intégré des soins d'urgence médicale (RISUM)
- C Le réseau des établissements médico-sociaux publics (REMSP)
- D Les structures spécialisées d'appui

44 Le Centre Hospitalier Ibn Sina est un :

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>A</b> | Etablissement public                       |
| <b>B</b> | Un service d'Etat géré de manière autonome |
| <b>C</b> | Un service d'Etat géré en régie            |
| <b>D</b> | Organisme privé                            |